

ריכוז תרופות במצבי חירום נשימתיים

אסתמה	אד-מאוס	אדרנלין	מגנזיום	אירובנט	אנטולין	אולומדרול
אנאפילקסיס	אסדו-א	אדרנלין	אולומדרול	אופמין	אנטולין	א-אירובנט רק לחולים שנטלים חסמי בטא
בצקת ריאות	אנדף	אזוקט	אטרולינגואל	אופמין	פוסיד	
COPD	אינהלציה +אולומדרול	אנטולין	אירובנט	אולומדרול		

הסבר:

COPD: מחלה כרונית, לא התקפית. הטיפול יחסית פשוט ופחות דחוף. אינהלציה וסולומדרול.
אנאפילקסיס: אנחנו יודעים שבאלרגיה נותנים אדרנלין. ולכן ה"א" היא אדרנלין ולא משהו אחר.
אסתמה: אין צורך בניטרטים ולכן ה"א" היא של האירובנט. (ולא איזוקט).
בצקת ריאות: ה"נ" של ניטרולינגואל אומרת שמטפלים בניטרטים ולכן ה"א" של איזוקט.

איזוקט רק בבצקת ריאות
מגנזיום רק באסתמה
פוסיד רק בבצקת ריאות
ניטרולינגואל רק בבצקת ריאות

תרופות	פעולה	התוויות נגד	1cc	אמפולה
אדרנלין	מרפה שריר חלק ומפחית הפרשות ברירות	הפרעות קצב מהירות (טכיאריטמיות); IHD.	1mg	1cc
איזוקט	ניטרטים. הרחבת שריר חלק בוורידים ובעורקים. והרחבת כלי הדם הכלילים	לחץ דם סיסטולי נמוך מ-100 mmHg; ירידה של 20% ויותר מתחת לערך הדיאסטולי שנמדד בתחילת הטיפול. שימוש בתרופות לאון אונות ב-36 השעות האחרונות חשד לאוטם ימני; היצרות קשה של המסתם האורטלי	1mg	10cc
אירובנט	אנטיכולינרגי להפחתת הפרשות וכיווץ סימפונות	רגישות יתר לתרופה; גלאוקומה (narrow angle)	0.25mg	20cc
דופמין	מעלה לחץ דם. ותפוקת הלב. חסם סלקטיבי להרחבת כלי דם חיוניים	פאוכרציטומה, הפרעות קצב מהירות (טאכיאריטמיות), לחץ דם גבוה (מעל 140 סיסטולי).	40mg	5cc
אנטולין	אגוניסט ל בטא2. מרחיב סימפונות	רגישות יתר ידועה.	5mg	20cc
מגנזיום סולפט	להרפיית שריר חלק.	אי-ספיקת כליות; חסמי הולכה; נזק ישן לשריר הלב.	0.5g	10cc
ניטרולינגואל	ניטרטים. הרחבת שריר חלק בוורידים ובעורקים. והרחבת כלי הדם הכלילים	לחץ דם סיסטולי נמוך מ-100 mmHg; ירידה של 20% ויותר מתחת לערך הדיאסטולי שנמדד בתחילת הטיפול. שימוש בתרופות אין אונות ב 36 השעות האחרונות היפואלמיה; חשד לאוטם ימני; היצרות קשה של המסתם האורטלי	0.4paf	
פוסיד	משתן. מוריד לחץ דם. מעלה פרפוזיה לכליות ומרחיב ורידי ריאה	התייבשות; היפוקלמיה; לחץ דם סיסטולי נמוך מ-80mmHg; תרדמת כבדית (hepatic coma)	10mg	2cc
אולומדרול	גלוקוקורטיקוסטרויד להפחתת דלקת.		62.5mg	2cc

החמרה ב COPD (אינה וסול)	אסתמה (אד מאוס)	אנפילקסיס (אסדו)
- ונטולין באינהלציה 2.5mg חד פעמי - אירובנט באינהלציה 0.5mg חד פעמי - סולמדורול 125mg חד פעמי בצקת ריאות (אנדפ) מטופל עם לחץ דם מעל 100 סיסטולי ניטרולינגואל SL - עד 3 מנות במינון של 0.4mg בתוך 3-5 דקות. - שקול מתן סיוע נשימתי באמצעות CPAP פוסיד - מנה חד פעמית במינון של 1mg/kg. - להכפיל את המנה היומית של מי לוקח פוסיד בקביעות - מינון מקסימלי 120mg שקול איזוקט בטפטוף (Drip) - מינון התחלתי – 20mcg/min. - מינון מקסימלי – 200mcg/min. שקול איזוקט ב PUSH 1-2mg כל 5–10 דקות. - יש למהול ל-50% מהריכוז המקורי. - מינון מקסימלי – 12mg/hr. מטופל עם לחץ דם מתחת ל 100 סיסטולי שקול דופמין 5-20mcg/kg/min - המינון הנמוך ביותר להשיג ל"ד 90 סיסטולי שקול פוסיד - מנה חד פעמית במינון של 1mg/kg. - להכפיל את המנה היומית של שמי שלוקח פוסיד בקביעות - מינון מקסימלי 120mg	מטופל בהתקף קל/בינוני אינהלציה - ונטולין 2.5 מ"ג. עד 3 מנות. בקבוק 100מ"ג/20מ"ל. לשאוב 0.5cc. - אירובנט 0.5 מ"ג. מנה חד פעמית בקבוק 5mg/20cc לשאוב 2cc להשלים עם סליין ל 5cc - סולומדרול 125מ"ג IV מנה חד פעמית. אמפולה 125mg/2cc מטופל בהתקף קשה - שקול מתן אדרנלין 0.3cc SC. שאב 0.3cc למזרק - אינהלציה - ונטולין 5 מ"ג. עד 3 מנות) בקבוק 100 mg/20cc. 1cc - אירובנט 0.5 מ"ג. עד 3 מנות. בקבוק 5mg/20cc - להשלים עם סליין ל 5cc - סולומדרול IV. 125mg מנה חד פעמית מטופל באי ספיקה נשימתית - אדרנלין IM. 0.5mg שאב 0.5cc למזרק 3cc - אינהלציה - ונטולין 2.5 מ"ג. עד 3 מנות - אירובנט 0.5 מ"ג. עד 3 מנות - להשלים עם סליין ל 5cc - מגנזיום סולפט 2גר' ב 100 מ"ל סליין תוך 10 דקות. אמפולה 5gr/10cc מנה חד פעמית - סולומדרול 125מ"ג IV. מנה חד פעמית - אם לא חל שיפור - שקול מתן סיוע נשימתי באמצעות CPAP - שקול מעבר לפרוטוקול ניהול מתקדם של נתיב אויר	מטופל במצב קל/בינוני אינהלציה - רק למטופלים הסובלים מתסמינים נשימתיים. - שקול ונטולין באינהלציה, מינון של 2.5-5mg - אם יש צורך, אפשר לתת עד 3 מנות בהפרש של 20 דקות בין המנות - שקול סולומדרול 125מ"ג IV מנה חד פעמית. אמפולה 125mg/2cc - שקול סליין – 1L/hr אם לא חל שיפור במצב המטופל - תן אדרנלין IM 03-05mg - שקול מתן אינהלציה ונטולין (רק למטופלים עם תסמינים נשימתיים). - תן סולומדרול 125mg חד פעמי - תן סליין 2-3L/hr אם לא חל שיפור במצב המטופל - שקול מתן אדרנלין IM 0.3-0.5mg - שקול מתן דופמין 5-20mcg/kg/min (רק אם יש סימני ירידה בפרפוזיה) - המשך עירוי סליין מטופל בדום לב - בצע החייאה מלאה על פי פרוטוקול - תן אדרנלין IV 1mg כל 2 דקות - תן עירוי סליין 4-5L/hr - תן סולומדרול 125mg

אסתמה	אנפילקסיס	קל/בינוני
תשאול - קוצר נשימה המופיע רק בזמן מאמץ/פעילות ללא קוצר נשימה במנוחה בדיקה גופנית קצב הנשימה נמוך מ-30 בדקה, אין שימוש בשרירי עזר, אין רטרקציות בין צלעיות, הסטורציה מעל 92% באוויר חדר, המטופל משלים משפטים ללא בעיות	אורטיקריה, נזלת או דמעת, קוצר נשימה קל מלווה בצפצופים, חולשה, פלפיטציות, בחילות, כאבי בטן.	
תשאול - קוצר נשימה המופיע גם במנוחה בדיקה גופנית - קצב הנשימה גבוה מ-30 בדקה, יש שימוש בשרירי עזר, יש רטרקציות בין צלעיות, הסטורציה מתחת 92% באוויר חדר, הדופק מעל 125 בדקה, המטופל מתקשה להשלים משפטים	אנגיואדמה, קוצר נשימה קשה, סימנים להיצרות דרכי נשימה עליונות (צרידות, סטרידור), הקאות, שלשולים.	קשה/ירידה בפרפוזיה
תשאול סביבתי. התדרדרות במצב המטופל במהלך השעות/היממה האחרונות/ה בדיקה גופנית -- המטופל בהכרה מעורפלת/אגיטיבי, נראה תשוש, מאמץ נשימתי "דל", הסטורציה מתחת 90% באוויר חדר ואינה משתפרת (או משתפרת קלות בלבד) עם חמצן		אי ספיקה נשימתית מאיימת
	סימנים לירידה בפרפוזיה, לחץ דם נמוך, דופק גבוה, ירידה בהכרה	שוק עמוק